SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE MEDICINA

MÓDULO 1 - 4º ANO/2025

SISTEMA LOCOMOTOR, CIRURGIA PLÁSTICA E GERIATRIA/ CUIDADOS PALIATIVOS

AVALIAÇÃO - N1 - MÓDULO 1 - TURMA A DATA 26/03/25

1. Paciente do sexo masculino, 45 anos, trabalhador braçal, apresenta dor no ombro direito há 3 meses, especialmente ao levantar o braço acima da cabeça e realizar movimentos de rotação. A dor piora à noite e durante atividades que envolvem levantamento de peso. O exame físico sugere síndrome do impacto e possível tendinite do tendão da cabeça longa do bíceps. A Manobra adequada para confirmar tendinite do tendão da cabeça longa do bíceps nesse paciente é a Manobra de

a) Neer.

b) Yergason.

c) Hawkins-Kennedy.

d) Jobe.

2. Paciente do sexo feminino, 38 anos, professora de educação física, apresenta dor no cotovelo direito há 4 meses. Refere piora da dor ao realizar movimentos de extensão do punho e ao levantar objetos. O exame físico revela sensibilidade sobre o epicôndilo lateral do cotovelo, sugerindo epicondilite lateral. A manobra apropriada para confirmar o diagnóstico de epicondilite lateral nesse caso é a Manobra de

a) Cozen.

b) Phalen.

c) Finkelstein.

d) Thompson.

3. Paciente do sexo feminino, 32 anos, com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico há 5 anos, apresenta fadiga, artralgias e rash malar recorrente nos últimos 3 meses. Refere piora progressiva da dor articular e episódios de febre baixa. O exame físico revela artrite em pequenas articulações das mãos e hiperemia malar. Os exames laboratoriais mostram: VHS = 55 mm/h (↑), PCR = 1,2 mg/dL (↑), complemento C3 e C4 reduzidos e anti-DNA positivo em altos títulos. O anticorpo anti-Ro também está positivo. Com base nesse contexto clínico e laboratorial, qual a principal interpretação dos achados?

a) Atividade inflamatória inespecífica, sem relação com a atividade do lúpus eritematoso sistêmico.

b) A positividade do anti-DNA em altos títulos está associada ao risco de nefrite lúpica.

c) Presença de sobreposição entre o lúpus eritematoso sistêmico e doença de Sjögren primária.

d) Ativação viral como principal explicação para as alterações laboratoriais, sem relação com a atividade do lúpus eritematoso sistêmico.

4. S.S.S., 67 anos, branca, feminina, compareceu no ambulatório de reumatologia referindo dor em IFDs e IFPs e joelhos há 10 anos anos, com rigidez matinal de 20 (ILEGÍVEL) no decorrer do dia e quando lava roupa. Ao exame (ILEGÍVEL) nódulos de Heberden e Bouchard, e crepitação em (ILEGÍVEL) do joelho D. (Questão com trecho parcialmente ilegível na dobra do papel.)

Quais as alterações encontrada na radiografia e o diagnóstico?



Radiografia da questão 4, preservada a partir da fotografia original.

a) Redução do espaço e lesão em saca bocado - gota

b) Esclerose subcondral e lesão em ponta de lápis - artrite psoriásica

c) Redução do espaço articular e esclerose subcondral- osteoartrite

d) Esclerose subcondral e erosões ósseas - artrite reumatóide.

5. Sobre a gota, assinale a alternativa correta:

a) é muito importante fazer a medida do ácido úrico sérico no início da crise, para confirma o diagnóstico.

b) classicamente se manifesta como monoartrite aguda, que se instala rapidamente em poucas horas, com dor muito intensa e sinais flogísticos na articulação acometida

c) apesar de poder manifestar-se com crises repetidas de artrite, não provoca problemas permanentes nas articulações acometidas.

d) controle da hiperuricemia devem ser indicado após a primeira crises sendo a droga de escolha a colchicina.

6. Mulher de 18 anos comparece com queixa de emagrecimento e dores no corpo, com piora progressiva nos últimos 2 meses. Ela nega sintomas neurológicos, respiratórios, urinários e gastrointestinais. Relata muita astenia, fraqueza e que as dores no corpo concentram-se nas mãos, nos joelhos e nos tornozelos. No momento da consulta, ela apresenta um bom estado geral, com mucosas descoradas moderadamente, com um úlceras orais, artrite nas interfalangeanas proximais das mãos e edema de membros inferiores ++. Ela traz os exames que foram realizados: hemoglobina = 9g/dL, hematócrito = 26%; 82.000 plaquetas; leucograma normal; urina I com ++ de proteína. De acordo com a principal hipótese diagnóstica assinale a alternativa que consta os exames que mais auxiliariam sua confirmação:

a) fator antinúcleo, e anticorpo anti-Sm

b) anti Ro e teste de Schirmer

c) dosagem de enzimas musculares e eletromiografia

d) fator reumatoide e complemento

7. A figura abaixo, extraída de "Reumatologia – Diagnóstico e Tratamento, 5ª ed, 2019", ilustra a fisiopatologia da osteoartrite, artropatia caracterizada por um desequilíbrio entre degradação e reparação cartilaginosa:

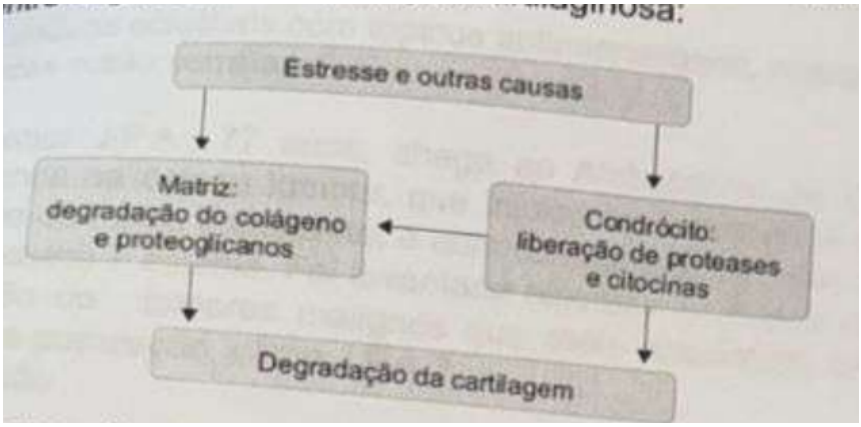


Figura da questão 7, preservada a partir da fotografia original.

Como demonstrado na figura, os condrócitos sintetizam proteases, por ação de diversas citocinas. Dentre as citocinas que atuam na síntese destas proteases, incluem-se:

a) IL-4, IL-10 e IL-13.

b) IL-1, IL-6 e TNF.

c) IL-2, IL-17 e IL-23.

d) IFN-alfa, IL-12 e IL-22.

8. Paciente de 38 anos, paraplégica há 20 anos, apresenta úlcera por pressão sobre o ísquio esquerdo. Foi submetida a tratamento cirúrgico onde foi realizado isquiectomia total com reconstrução com retalho glúteo maior. A complicação mais frequente que poderá ocorrer neste pós-operatório é:

a) Hipovolemia no pós-operatório imediato

b) Necrose total do retalho glúteo

c) Fístula uretro-cutânea

d) Aparecimento de úlcera por pressão em ísquio contra-lateral

9. Paciente 18 anos, masculino, teve queda de escada com trauma direto sobre o hemicorpo Direito, e evoluiu com os seguintes sintomas na primeira hora na topografia de cotovelo.

I- dor local
II- edema ou deformidade
III- hematoma
IV- crepitação ao movimentar ou incapacidade funcional do membro
Qual sua principal hipótese?

a) Lesão de nervo interósseo posterior

b) Fratura de rádio proximal

c) Fratura de úmero proximal

d) Luxação articulação radiocarpal

10. Na displasia do desenvolvimento do quadril, podemos dizer que o quadril instável é aquele que:

a) Está reduzido e luxa quando fazemos manobra de abdução

b) É aquele que tem a cabeça femural com 50% de cobertura pelo acetábulo

c) Está reduzido e luxa quando realizamos manobra de adução

d) Apresenta incongruência entre a epífise femural e o acetábulo

11. Quais os primeiros cuidados com uma criança com queimaduras provocadas por líquidos aquecidos e que atingiram 20% de área corporal, sendo aproximadamente 15% de segundo grau e 5% de terceiro grau?

a) Cateterização de uma veia periférica e hidratação com soro ringer lactato

b) Cateterização vesical e gástrica

c) Curativos oclusivos com tópicos antimicrobianos, internação em UTI

d) Todas estão corretas

12. Senhor J.P.A., 77 anos, chega ao Ambulatório de Ortopedia, com queixa de dor intensa na coluna lombar, que iniciou há 2 meses. A dor é contínua, porém piora a noite de forma importante, e com os movimentos, vem tendo perda de peso (10kg em 3 meses) e astenia. Foi levantada hipótese de fratura de vértebra por metástase Qual opção de tumores malignos que mais ocasionam metástases na coluna vertebral nesta população, como J.P.A.?

a) Pulmão

b) Rins

c) Próstata

d) Fígado

13. Adulto jovem, 28 anos, foi vítima de politrauma por atropelamento. Você como plantonista do Pronto-Socorro, e baseado no conhecimento do que é preconizado pelo ATLS, quais radiografia solicitaria?

a) RX em perfil da coluna cervical, AP do tórax e AP da bacia;

b) RX em perfil da coluna cervical, AP do tórax e AP do abdome;

c) RX em AP da coluna cervical, AP do tórax e AP da bacia;

d) RX em perfil da coluna cervical, perfil do tórax e AP do abdome.

14. Um paciente com 6 meses de trauma raquimedular apresenta ao exame físico: Babinsky, clônus de membros inferiores e reflexo de Hoffmann positivo. Qual a altura provável da lesão do paciente?

a) C4C5

b) T8T9

c) T12L1

d) L4L5

15. Para avaliação de sintomas utiliza-se em Cuidados Paliativos:

a) Questionário de funcionalidade de Pfeffer

b) Escala de Performance Paliativa (PPS)

c) Escala de Avaliação de Sintomas de Edmonton (ESAS)

d) Escala Clínica de Fragilidade (ECF)

16. Mulher de 87 anos, portadora de doença de Alzheimer em fase grave, faz uso de donepezila, memantina, sertralina e olanzapina. Além disso, utiliza valsartana, anlodipina, hidroclorotiazida para hipertensão; metformina e glibenclamida para diabetes; sinvastatina para controle da dislipidemia;

corticosteroide em baixa dose para osteoartrite; alendronato, cálcio e vitamina D para osteoporose; e paracetamol para dores eventuais. Acompanhantes relatam que a paciente começou a apresentar frequentes recusas ou dificuldades para ingerir as medicações. Nesse caso, assinale a conduta mais adequada.

a) Amassar e dissolver todos os medicamentos de uso habitual nos alimentos e líquidos.
b) (ILEGÍVEL) um medicamento inibidor de bomba de prótons para proteção gástrica.
c) (ILEGÍVEL) nasoenteral para garantir o fornecimento de todos os medicamentos.
d) (ILEGÍVEL) prescrição e avaliar a desprescrição dos medicamentos inapropriados.

17. (ILEGÍVEL) de 78 anos é levado ao ambulatório de Geriatria pelo filho que refere que, há (ILEGÍVEL) de 1 ano, o pai começou a apresentar episódios de confusão, irritabilidade e comportamento agressivo, tendo se perdido nas ruas do bairro em que mora por 2 vezes. Associado a isso, ele tem apresentado episódios de desequilíbrio com quedas frequentes e escapes urinários, com necessidade de uso de fraldas, principalmente à noite, quando acorda frequentemente relatando a presença de pessoas estranhas em seu quarto. Durante a anamnese e avaliação clínica, apresentava-se apático e com marcha instável, além de rigidez de movimentos e tremores de membros superiores. O Mini Exame do Estado Mental foi de 26 pontos e o Questionário de Pfeffer de 27 pontos. Qual é a hipótese mais provável?

a) Delirium hiperativo.
b) Demência por Corpos de Lewy.
c) Doença de Alzheimer.
d) Demência da Doença de Parkinson.

18. O conceito de funcionalidade é muito discutido nas avaliações geriátricas. Em relação a esse tema, é correto afirmar que:

a) não é necessária a avaliação de funcionalidade, para o diagnóstico de demências.
b) pacientes classificados como dependentes certamente têm o diagnóstico de demência.
c) existem diversas escalas validadas para a avaliação de funcionalidade, sendo uma delas o MoCa (Montreal Cognitive Assessment).
d) avalia a capacidade de o idoso cuidar de si mesmo e do ambiente onde vive.

19. Em uma Síndrome Geriátrica observa-se:

a) múltiplas alterações fisiopatológicas que concorrem simultaneamente para um conjunto de sinais e sintomas.
b) múltiplas alterações fisiopatológicas que concorrem sequencialmente para único sinal clínico.
c) uma única alteração fisiopatológica que resulta em um conjunto de sinais e sintomas.
d) uma única alteração fisiopatológica que resulta em único fenômeno clínico.
e) um conjunto de sinais e sintomas no qual não se consegue definir nenhuma alteração fisiopatológica causal.

20. Homem, de 74 anos, professor aposentado, portador de hipertensão e fibrilação atrial, ficou viúvo há um ano e a filha, que foi morar com o pai, observou que ele vinha apresentando perda progressiva de memória, pois observou que ele começou a fazer confusão com os medicamentos de uso habitual, esqueceu várias vezes a senha do banco, fez uma retirada de sua conta e não se lembra para que usou o dinheiro, além de ter se perdido uma vez ao ir a paróquia, caminho que conhecia muito bem, pois residia no mesmo bairro há mais de 30 anos. Apesar dessas dificuldades, ele não tinha incontinência e era capaz de alimentar-se e andar sem ajuda, tomar banho e vestir-se adequadamente e fazer a barba

e a própria higiene. as dificuldades apresentadas pelo paciente caracterizavam incapacidade para executar as:

a) atividades básicas de vida diária.

b) atividades avançadas de vida diária.

c) atividades instrumentais de vida diária.

d) atividades básicas e instrumentais de vida diária.

GABARITO COMENTADO

Avaliação N1 - Módulo 1 - Turma A, 26/03/2025

Elaboração independente: foram desconsideradas eventuais marcações de respostas. As seis páginas anteriores reúnem as 20 questões fornecidas, com preservação das duas figuras relevantes (questões 4 e 7). Este apêndice diferencia resposta mais adequada, limitação do enunciado e eventual atualização clínica.

Legenda: respostas acompanhadas de «provável» ou «histórico» exigem leitura das ressalvas, não constituindo afirmação de certeza absoluta.

GABARITO RESUMIDO

01 B	**06 A**	**11 D**	**16 D**
02 A	**07 B**	**12 C**	**17 B**
03 B	**08 D**	**13 A**	**18 D**
04 C	**09 B**	**14 A**	**19 A**
05 B	**10 C**	**15 C**	**20 C**

Questões que requerem cautela: 8 (frequência da complicação), 9 (fratura específica não comprovada), 11 (condutas condicionadas à gravidade), 13 (mudança nos protocolos de trauma) e 16 (alternativa parcialmente ilegível).

JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS

QUESTÃO 01 | Manobras do ombro

Resposta sugerida: B

A - INCORRETA. Neer é manobra de impacto subacromial, não teste dirigido especificamente ao tendão bicipital.

B - CORRETA. Yergason solicita supinação resistida e pode reproduzir dor no sulco bicipital, sugerindo afecção da cabeça longa do bíceps. O teste não confirma isoladamente a lesão.

C - INCORRETA. Hawkins-Kennedy provoca sintomas de impacto subacromial.

D - INCORRETA. Jobe (empty-can) explora sobretudo o músculo/tendão supraespinal.

Fundamentação: [1].

QUESTÃO 02 | Dor na região do epicôndilo lateral

Resposta sugerida: A

A - CORRETA. Cozen provoca dor epicondilar lateral ao solicitar extensão resistida do punho.

B - INCORRETA. Phalen avalia compressão do nervo mediano na síndrome do túnel do carpo.

C - INCORRETA. Finkelstein investiga tenossinovite de De Quervain no punho.

D - INCORRETA. Thompson pesquisa ruptura do tendão de Aquiles por compressão da panturrilha.

Fundamentação: [2].

QUESTÃO 03 | Autoanticorpos e atividade do lúpus

Resposta sugerida: B

A - INCORRETA. Anti-dsDNA elevado, hipocomplementemia e atividade articular/cutânea favorecem atividade do LES, não simples inflamação inespecífica.

B - CORRETA. Títulos elevados de anti-DNA de dupla hélice, sobretudo com C3/C4 baixos, associam-se a atividade do LES e maior atenção ao comprometimento renal; não bastam para diagnosticar nefrite.

C - INCORRETA. Anti-Ro positivo isoladamente não diagnostica síndrome de Sjögren; seriam necessários achados clínicos e critérios próprios.

D - INCORRETA. Infecção viral pode simular exacerbações, mas não constitui a principal interpretação do conjunto apresentado.

Fundamentação: [3], [6].

QUESTÃO 04 | Osteoartrite e imagem do joelho

Resposta sugerida: C

A - INCORRETA. Erosões em saca-bocado, frequentemente com bordas salientes, lembram gota crônica, não explicam melhor o conjunto clínico.

B - INCORRETA. Deformidade em lápis-na-taça é própria da artrite psoriásica avançada, não do padrão ilustrado.

C - CORRETA. Redução do espaço articular e esclerose subcondral, com rigidez curta, crepitação e nódulos de Heberden/Bouchard, apontam para osteoartrite.

D - INCORRETA. Artrite reumatoide produz tipicamente erosões marginais e osteopenia periarticular, sem os clássicos nódulos de Heberden/Bouchard.

Fundamentação: [4].

QUESTÃO 05 | Crise aguda de gota

Resposta sugerida: B

A - INCORRETA. A uricemia pode estar normal durante uma crise; sua medida isolada não confirma gota. A demonstração de cristais de urato no líquido sinovial é referência diagnóstica.

B - CORRETA. A apresentação clássica é monoartrite de instalação em horas, muito dolorosa, com calor, rubor e edema.

C - INCORRETA. Crises repetidas e gota tofácea podem produzir erosões e dano articular permanente.

D - INCORRETA. Colchicina trata ou previne crises, mas não reduz urato. A indicação de terapia hipouricemiante após a primeira crise é seletiva, não universal; quando indicada, alopurinol costuma ser primeira escolha.

Fundamentação: [5].

QUESTÃO 06 | Suspeita de lúpus sistêmico com possível comprometimento renal

Resposta sugerida: A

A - CORRETA. FAN é exame de triagem sensível e anti-Sm é altamente específico para LES, coerente com úlceras orais, artrite, citopenias e proteinúria.

B - INCORRETA. Anti-Ro e teste de Schirmer são úteis especialmente na investigação de Sjögren, não constituindo a dupla mais esclarecedora aqui.

C - INCORRETA. Enzimas musculares e eletromiografia avaliam miopatias inflamatórias, não explicando adequadamente citopenias e proteinúria.

D - INCORRETA. Fator reumatoide não é específico e complemento isolado não confirma o diagnóstico. Seriam úteis também anti-dsDNA, C3/C4, função renal e quantificação da proteinúria.

Fundamentação: [6], [3].

QUESTÃO 07 | Citocinas associadas à degradação da cartilagem

Resposta sugerida: B

A - INCORRETA. IL-4, IL-10 e IL-13 têm perfis predominantemente imunorreguladores/anti-inflamatórios em comparação ao grupo solicitado.

B - CORRETA. IL-1, IL-6 e TNF-alfa estimulam mediadores catabólicos e metaloproteinases produzidos por condrócitos, contribuindo para degradação da matriz.

C - INCORRETA. IL-17 pode participar da inflamação, mas IL-2 e IL-23 não formam o trio clássico enfatizado nesse mecanismo.

D - INCORRETA. IFN-alfa, IL-12 e IL-22 não correspondem ao conjunto central descrito no esquema.

Fundamentação: [7].

QUESTÃO 08 | Isquiectomia por úlcera de pressão

Resposta sugerida: D (provável)

A - INCORRETA. Hipovolemia pode ocorrer em cirurgias, mas não é a complicação particular mais esperada dessa técnica.

B - INCORRETA. Necrose total do retalho é evento possível, porém não é a consequência mecânica típica da retirada do ísquio.

C - INCORRETA. Fístula uretrocutânea é complicação relatada, mas incomum e geralmente relacionada a ulcerações perineais extensas.

D - MAIS ADEQUADA. A isquiectomia unilateral redistribui a carga ao ísquio oposto, favorecendo nova úlcera contralateral. O enunciado usa «mais frequente» sem quantificar o risco; a associação causal é bem descrita, mas não há base para afirmar frequência universal.

Fundamentação: [8].

QUESTÃO 09 | Trauma localizado no cotovelo

Resposta sugerida: B (provável; dados limitados)

A - INCORRETA como hipótese principal. Lesão isolada de nervo interósseo posterior exige achado motor específico, não fornecido.

B - MAIS PLAUSÍVEL. Fratura do rádio proximal pode causar dor, edema, crepitação e incapacidade na região do cotovelo após trauma.

C - INCORRETA para a topografia informada. Fratura proximal do úmero costuma gerar manifestações na região do ombro, não no cotovelo.

D - INCORRETA. Luxação radiocarpal acomete o punho. RESSALVA: o enunciado não descreve dor à palpação da cabeça do rádio, limitação de pronossupinação ou radiografia; não é possível confirmar a fratura específica.

QUESTÃO 10 | Quadril instável na displasia do desenvolvimento

Resposta sugerida: C

A - INCORRETA. A abdução integra a manobra de Ortolani, utilizada para reduzir a luxação; não é o mecanismo provocativo clássico.

B - INCORRETA. Cobertura acetabular de 50% é informação de avaliação por imagem, não a definição clínica de quadril luxável.

C - CORRETA. O quadril reduzido, porém deslocável por adução suave com manobra de Barlow, é instável.

D - INCORRETA. Incongruência pode caracterizar quadril já luxado, mas não define especificamente o quadril reduzido e luxável.

Fundamentação: [9].

QUESTÃO 11 | Primeiros cuidados da criança queimada

Resposta sugerida: D (provável; ressalvas)

A - ADEQUADA. Acesso venoso e reposição de cristaloide, geralmente Ringer lactato, fazem parte do atendimento inicial de queimaduras extensas.

B - ADEQUADA conforme extensão e protocolo. Cateter vesical permite acompanhar a diurese; sonda gástrica pode ser necessária em queimaduras extensas e risco de íleo, mas não é obrigatória para toda criança.

C - ADEQUADA em contexto selecionado. Curativos apropriados e avaliação por centro de queimados são importantes; internação em UTI depende de gravidade e recursos, não apenas de uma regra rígida para toda queimadura de 20%.

D - RESPOSTA PROVAVELMENTE PRETENDIDA. Integra medidas potencialmente apropriadas, mas «todas» pressupõe indicação individual das sondas e do nível de internação. Avaliação ABCDE e analgesia também são prioritárias.

Fundamentação: [10], [11], [19].

QUESTÃO 12 | Metástases vertebrais em homem idoso

Resposta sugerida: C

A - INCORRETA como resposta preferencial no perfil descrito. Pulmão também é origem frequente de metástases ósseas, não sendo uma hipótese descartável.

B - INCORRETA como mais frequente no perfil. Carcinoma renal pode metastatizar para o esqueleto, porém é menos prevalente que próstata na população masculina idosa.

C - CORRETA no contexto. Câncer de próstata é uma das causas principais de metástases ósseas/vertebrais em homens idosos; as lesões são frequentemente osteoblásticas.

D - INCORRETA. Fígado não é fonte usualmente principal de metástases vertebrais nessa faixa clínica. Ressalva: frequências variam conforme a população estudada.

Fundamentação: [18].

QUESTÃO 13 | Exames de imagem no politrauma e mudanças no ATLS

Resposta sugerida: A (gabarito histórico)

A - MELHOR ENTRE AS OPÇÕES DA PROVA ANTIGA: perfil da cervical, AP de tórax e AP de pelve reproduzem o conjunto clássico de radiografias auxiliares do atendimento ao trauma.

B - INCORRETA. Radiografia AP de abdome não substitui a avaliação da pelve como adjunto convencional no contexto fornecido.

C - INCORRETA. Projeção AP isolada da cervical não é exame adequado para excluir lesão cervical.

D - INCORRETA. Perfil de tórax e AP de abdome não correspondem à sequência tradicional. ATUALIZAÇÃO: no trauma moderno, a indicação de imagem é individualizada e a TC é preferível à radiografia simples para investigação cervical quando necessária; não se devem atrasar medidas de ressuscitação para obter radiografias.

Fundamentação: [17].

QUESTÃO 14 | Sinais de lesão piramidal nos quatro membros

Resposta sugerida: A

A - CORRETA. Lesão medular cervical em C4-C5 é compatível com Hoffmann positivo e sinais de primeiro neurônio motor em membros inferiores.

B - INCORRETA. Lesão torácica T8-T9 justifica sinais piramidais em pernas, mas não explica de modo consistente Hoffmann patológico em membros superiores.

C - INCORRETA. Lesão em T12-L1 não esclarece o acometimento de vias motoras dos membros superiores.

D - INCORRETA. L4-L5 é nível lombar, predominantemente de raízes, não explicando esse conjunto de reflexos patológicos. Os reflexos não definem com precisão um nível vertebral sem exame completo e imagem.

Fundamentação: [12].

QUESTÃO 15 | Instrumento para avaliação de sintomas em cuidados paliativos

Resposta sugerida: C

A - INCORRETA. Pfeffer avalia atividades instrumentais e funcionalidade, frequentemente em avaliação cognitiva.

B - INCORRETA. PPS mensura estado de desempenho e funcionalidade paliativa, não a intensidade individual de sintomas.

C - CORRETA. ESAS quantifica sintomas como dor, fadiga, náusea, ansiedade e dispneia, usualmente de 0 a 10.

D - INCORRETA. Escala Clínica de Fragilidade avalia grau de fragilidade global, não a carga sintomática específica.

Fundamentação: [15].

QUESTÃO 16 | Desprescrição em demência avançada

Resposta sugerida: D (pela parte legível)

A - INCORRETA. Nem todos os comprimidos podem ser amassados; isso pode modificar liberação, segurança e absorção, além de não resolver prescrição excessiva.

B - INCORRETA. Introduzir IBP sem indicação apenas aumenta a carga farmacológica.

C - INCORRETA como medida geral. Sonda nasoenteral não deve ser instituída apenas para manter todas as medicações, sobretudo diante de objetivos de conforto e possível desprescrição.

D - MAIS ADEQUADA. Rever integralmente a prescrição e considerar retirada criteriosa de fármacos de benefício remoto ou risco desproporcional. O início da alternativa encontra-se ilegível no PDF, mas a parte disponível sustenta essa leitura.

Fundamentação: [13], [20].

QUESTÃO 17 | Demência com corpos de Lewy

Resposta sugerida: B

A - INCORRETA. Delirium possui início agudo/flutuante e costuma ser precipitado por condição médica; a evolução de aproximadamente um ano favorece transtorno neurocognitivo.

B - CORRETA. Alucinações visuais formadas, parkinsonismo e declínio cognitivo temporalmente associados sustentam demência com corpos de Lewy.

C - INCORRETA como explicação principal. Alzheimer isolado costuma ter predomínio de déficit de memória episódica e não explica tão bem alucinações precoces com parkinsonismo.

D - MENOS PROVÁVEL. Demência da doença de Parkinson é preferida quando doença de Parkinson estabelecida precede a demência por mais de um ano; isso não foi descrito.

Fundamentação: [14].

QUESTÃO 18 | Conceito de funcionalidade geriátrica

Resposta sugerida: D

A - INCORRETA. Avaliar impacto funcional é fundamental para caracterizar comprometimento neurocognitivo maior.

B - INCORRETA. Dependência pode decorrer de doenças motoras, sensoriais, sociais ou outras causas, sem demência.

C - INCORRETA. MoCA é teste cognitivo, não escala específica de atividades da vida diária.

D - CORRETA. Funcionalidade compreende autonomia e capacidade nas atividades básicas, instrumentais e no manejo do ambiente.

Fundamentação: [16].

QUESTÃO 19 | Síndromes geriátricas e multifatorialidade

Resposta sugerida: A

A - CORRETA. Síndromes geriátricas habitualmente surgem da interação simultânea de vários fatores fisiopatológicos e ambientais, gerando manifestações clínicas.

B - INCORRETA. Sequência de causas para um único sinal não representa o conceito abrangente da síndrome geriátrica.

C - INCORRETA. Um único mecanismo causal caracteriza melhor doença ou processo específico, não a natureza multifatorial típica.

D - INCORRETA. Uma causa isolada e uma manifestação isolada não traduzem a síndrome geriátrica.

E - INCORRETA. Multifatorialidade não significa ausência de causas identificáveis; os componentes frequentemente podem ser investigados.

Fundamentação: [16].

QUESTÃO 20 | Atividades instrumentais de vida diária

Resposta sugerida: C

A - INCORRETA. Alimentação, banho, higiene e vestuário (atividades básicas) estão preservados no caso.

B - INCORRETA. Atividades avançadas incluem participação social complexa e lazer; não são a melhor categoria para finanças e administração de remédios.

C - CORRETA. Administrar medicamentos, lidar com finanças e deslocar-se autonomamente são atividades instrumentais, comprometidas na descrição.

D - INCORRETA. Não há evidência de perda das atividades básicas mencionadas na alternativa.

Fundamentação: [16].

REFERÊNCIAS CONSULTADAS

Seleção de diretrizes, consensos e estudos utilizados para a verificação independente do gabarito. As fontes são indicadas em cada questão pelo número entre colchetes.

[1] Cardoso A. et al., 2019. Testes clínicos do tendão da cabeça longa do bíceps. J Shoulder Elbow Surg. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31500987/

[2] AAFP. Evaluation of Elbow Pain in Adults (exame da epicondilite lateral). https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2014/0415/p649.html

[3] EULAR. Recomendações para manejo do lúpus eritematoso sistêmico, 2019. https://ard.bmj.com/content/78/6/736

[4] ACR/Arthritis Foundation. Diretriz para osteoartrite da mão, quadril e joelho, 2019. https://acrjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/art.41142

[5] ACR. Diretriz de tratamento da gota, 2020. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10563586/

[6] EULAR/ACR. Critérios classificatórios de LES, 2019. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6827566/

[7] Review. Therapeutics in osteoarthritis based on molecular pathogenesis. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5877535/

[8] Karaca A et al. Complications of total ischiectomy for ischial pressure sores, 1978. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/662970/

[9] American Academy of Pediatrics. Developmental dysplasia of hip, 2016. https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/138/6/e20163107/52541/Evaluation-and-Referral-for-Developmental

[10] American Burn Association. Burn Patient Referral Guidelines. https://www.ameriburn.org/burn-care-team/resources/guidelines-for-burn-patient-referral

[11] Pediatric Burn Initial Management. LAAAP clinical guide. https://www.laaap.org/initial-management-pediatric-burn-patient

[12] Review. Cervical myelopathy and neurologic signs, WFNS Spine Committee, 2019. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6790728/

[13] American Geriatrics Society. 2023 Beers Criteria. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12478568/

[14] DLB Consortium. Fourth consensus report on Lewy body dementia, 2017. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5496518/

[15] Canadian Virtual Hospice. Edmonton Symptom Assessment System - Revised. https://content.virtualhospice.ca/content/resources/esas-r-edmonton-symptom-assessment-system-revised/?resourcePageId=19092

[16] National Academies. Functional assessment - Basic and instrumental activities. https://www.nationalacademies.org/read/25376/chapter/6

[17] American College of Surgeons. ATLS 11th ed. 2025 - coluna cervical e radiografia no trauma (síntese por publicação do manual). https://studylib.net/doc/28118461/atls-11thedition-course-manual-2025

[18] Metastatic bone disease: spine metastases and prostate cancer. Review/NCBI Bookshelf. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441950/

[19] American Burn Association. Burn Shock Resuscitation Clinical Practice Guidelines 2024 (aplicável a adultos; ver limite). https://academic.oup.com/jbcr/article/45/3/565/7458089

[20] US National Institute on Aging. Care of older adults with cognitive impairment and medication review. https://www.nia.nih.gov/health/health-care-professionals-information/caring-older-patients-cognitive-impairment